

CONCURSO PÚBLICO
INGÁ (PB): SUPERIOR (TARDE)



MÉDICO PSIQUIATRA

80 QUESTÕES OBJETIVAS

igeduc

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens a seguir.

01. A esquizofrenia e os denominados transtornos esquizofrênicos constituem um grupo de distúrbios mentais graves, sem sintomas patognomônicos, mas caracterizados por distorções do pensamento e da percepção, delírios, alucinações, pensamentos e fala desorganizados, por inadequação e embotamento do afeto sem prejuízo da capacidade intelectual.
02. O delirium é definido como uma turvação aguda nos níveis de consciência e cognição de um indivíduo, geralmente reversível. É causado frequentemente por infecção (pulmonar, urinária e intestinal), distúrbio metabólico (como: doença renal aguda, hiponatremia) ou medicamentos utilizados pelo paciente.
03. Os pacientes com esquizofrenia apresentam alucinações auditivas, como vozes de comando, não sendo possível apresentarem alucinações visuais ou comportamento bizarro.
04. O acolhimento universal representa o acesso a serviços que devem ter as portas abertas a todos aqueles que chegam com alguma necessidade de saúde e de saúde mental. Isso não significa que os serviços de saúde e de saúde mental tenham que atender e acompanhar todos os casos que até ali chegam, mas deve existir uma abordagem para identificar as necessidades de cada situação, propor alguma intervenção inicial e, quando couber, oferecer outras estratégias e lugares de tratamento.
05. Os laudos são peças oficiais que servem para instruir o processo, e constituem prova pericial. Laudo de saúde mental é o nome que se dá ao relatório escrito do exame de sanidade mental, com suas conclusões legais e respostas aos quesitos.
06. As psicoses agudas são síndromes que se manifestam na forma de alucinações, delírios, pensamento desorganizado, comportamento pouco usual, inquietação e agitação psicomotora, mas nunca na forma catatônica.
07. A esquizofrenia, na fase aguda ou produtiva da doença, manifesta-se apenas através de delírios de grandeza.
08. Transtornos de tique são definidos como movimentos musculares súbitos, rápidos, repetitivos e não rítmicos, incluindo sons ou vocalizações. Os tiques são tratados apenas se interferirem nas atividades da criança ou na autoimagem; o tratamento pode incluir intervenção comportamental abrangente para tiques e agonistas alfa-adrenérgicos ou antipsicóticos.
09. Os transtornos do humor são transtornos de saúde mental, nos quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva (depressão), de exaltação excessiva ou de euforia (mania), ou ambos. A depressão e a mania representam os dois extremos opostos, ou polos, dos transtornos do humor.
10. Existem alguns transtornos mentais relacionados com a ansiedade e medo, dentre eles está a agorafobia, que é a sensação de pânico em lugares altos.
11. O objetivo dos cuidados paliativos é resgatar a possibilidade da morte como um evento natural e esperado na presença de doença ameaçadora da vida, colocando ênfase na vida que ainda pode ser vivida com uma melhor qualidade.
12. São sintomas do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade em adultos: agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, inquietação das mãos e pés, necessidade de toque em vários objetos, dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas ou que não lhes sejam interessantes. As pessoas que apresentam esse transtorno são facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos.
13. Os transtornos de humor não ocorrem em episódios depressivos com sintomas de tristeza profunda, irritação, anedonia, pensamentos de ruína e lassidão.
14. Em saúde mental, o genograma é um instrumento essencial para o profissional de saúde que trabalha com famílias, pois permite descrever e ver como uma família funciona e interage. A família pode ser crucial na prevenção de doenças, na recuperação de um paciente.
15. Os déficits encontrados nos pacientes com retardo mental (deficiência intelectual) envolvem a cognição e o comportamento adaptativo, sempre com início após os 22 anos.

16. Para a confirmação do diagnóstico de esquizofrenia, exige-se a presença de pelo menos uma das síndromes, sintomas ou sinais de um grupo de maior hierarquia, ou pelo menos dois dos sinais e sintomas de um grupo de menor hierarquia. Faz parte do grupo de sintomas de maior hierarquia: as alucinações persistentes, de qualquer modalidade, quando ocorrerem todos os dias, por pelo menos 1 mês, quando acompanhadas por delírios (os quais podem ser superficiais ou parciais), sem conteúdo afetivo claro ou quando acompanhadas por ideias superestimadas persistentes.
17. O transtorno de personalidade social é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade em relacionamentos, autoimagem, humor e comportamento, bem como hipersensibilidade à possibilidade de rejeição e abandono.
18. A descriminalização e o estigma social estão presentes no mundo devido a sua real ou pressuposta orientação sexual ou identidade de gênero. As pessoas lésbicas, gays e transgênero são significativamente mais propensas do que a população em geral a serem sujeitadas a violência e abuso, contrair o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e estar vulneráveis a questões de saúde mental, como depressão e suicídio.
19. De forma geral, alguns sintomas relacionados com os transtornos mentais causados por ansiedade excessiva são: respiração ofegante, falta de ar, dormência, formigamento, palpitações, suor excessivo, mãos frias, visão turva, taquicardia, fala acelerada, dor de barriga e agitação nas pernas.
20. A depressão é um dos transtornos psiquiátricos mais comuns entre as pessoas idosas. As mulheres apresentam prevalências maiores que os homens na proporção de 2:1. A depressão leve representa a presença de sintomas depressivos frequentemente associados ao alto risco de desenvolvimento de depressão maior, doença física, maior procura pelos serviços de saúde e maior consumo de medicamentos.
21. Conforme a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, a internação psiquiátrica voluntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido.
22. A adolescência é fase de vida em que ocorre a transição da infância para a vida adulta, acarretando importantes transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Na etapa média, dos 15 aos 17 anos, os adolescentes apresentam as características como: máxima identificação com o grupo de iguais; puberdade e início das experiências sexuais e modificação da imagem corporal.
23. A assistência a usuários de álcool deve ser oferecida em todos os níveis de atenção do sistema único de saúde (SUS), privilegiando os cuidados com os serviços intra-hospitalares, como os Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS ad), devendo também estar inserida na atuação do Programa de Saúde da Família (PSF), Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e da Rede Básica de Saúde (RBS).
24. De modo geral, os transtornos por uso de substâncias incluem padrões de comportamento nos quais a pessoa continua a usar a substância. A intoxicação diz respeito a sintomas que aparecem quando a pessoa para de tomar a substância ou toma uma quantidade muito menor do que a normal.
25. Apenas os fatores pré-natais estão associadas ao retardo mental (deficiência intelectual), o qual costuma ser identificado com o auxílio de exames de sangue.
26. A Doença de Alzheimer é uma doença neuro degenerativa, progressiva e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, causando o comprometimento progressivo das atividades da vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. A doença é consequência de falhas de certas proteínas do sistema nervoso central.
27. O tipo mais conhecido de psicoterapia é a psicanálise, criada pelo psicólogo Sigmund Freud. O paciente se deita em um divã, relata os problemas que o levaram até o consultório. O terapeuta, por sua vez, estimula que o próprio indivíduo reflita e encontre soluções com base nas sugestões do profissional.
28. O Centro de Atenção Psicossocial III atende pessoas maiores de 18 anos que apresentam sofrimento mental grave e persistente. É composto por uma equipe mínima de 2 médicos psiquiatras; 1 enfermeiro com formação em saúde mental; 5 profissionais de nível superior de outras categorias profissionais; 8 profissionais de nível médio.
29. Nos casos de transtorno de déficit de atenção, a avaliação médica tem por foco a identificação de condições que possam contribuir potencialmente e sejam tratáveis, ou identificar sinais e sintomas. Nessa avaliação, inclui-se a história de exposição pré-natal, complicações ou infecções perinatais, infecções do sistema nervoso central, traumatismo cranioencefálico, doença cardíaca, respiração durante o sono, falta de apetite e/ou alimentação seletiva e história familiar.
30. São consideradas urgências psiquiátricas os casos de pacientes que apresentam alterações psíquicas ou comportamentais que indiquem risco iminente à integridade física do indivíduo. O delírium associado ao rebaixamento da consciência é um tipo de urgência psiquiátrica cérebro-orgânicas.
31. A utilização de um roteiro norteador pode ajudar na organização de um Projeto Terapêutico Singular (PTS), estabelecendo momentos sobrepostos, são eles: o diagnóstico situacional, a definição de objetivos e metas, a divisão de tarefas e responsabilidades e a reavaliação do PTS.
32. A área de atuação de um perito forense abrange um amplo campo no conhecimento da ciência. Um perito especialista em direito da família pode colaborar em tomadas de decisões referentes à guarda dos filhos, quando uma das partes afirma que a outra é incapaz de se responsabilizar por uma guarda compartilhada, devido a uma doença mental.

33. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, é instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências não ocultas.
34. A Política Nacional de Atenção Básica inclui, entre o conjunto de ações que caracteriza uma atenção integral à saúde a promoção, a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Essa estratégia de redução de danos é norteadora apenas para as práticas de cuidado de pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas.
35. A intersetorialidade é uma estratégia fundamental de promoção da saúde, que busca o alcance de determinantes de saúde favoráveis à saúde dos indivíduos e comunidades.
36. Conforme a rede de atenção psicossocial (RAPs), fazem parte da atenção de urgência e emergência: o Samu 192; a sala de estabilização; a UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro, unidades básicas de saúde e Unidade de acolhimento.
37. A avaliação cognitiva deve fazer parte da avaliação clínica na saúde mental das pessoas idosas. O desempenho físico e social do idoso não depende da integridade de suas funções cognitivas. A perda de memória recente e a habilidade de cálculo são indicadores sensíveis de redução dessas funções.
38. A abstinência de substâncias psicotrópicas não está relacionada a episódios de psicose.
39. Os transtornos de humor podem ocorrer apenas em episódios maníacos com sintomas de euforia. Assim, não é possível ocorrerem durante episódios de delírios de grandeza ou agitação.
40. O ataque do pânico ou síndrome do pânico é quando a pessoa sente nervosismo e preocupação excessivos em relação a diversas atividades ou acontecimentos. O número de dias em que a pessoa tem ansiedade é superior ao número de dias em que não tem, por um período de seis meses ou mais.
41. A deficiência intelectual é diagnosticada quando o indivíduo apresenta um funcionamento intelectual inferior à média. O diagnóstico deverá ser confirmado tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Dentre esses testes, o mais utilizado é o Quociente de Inteligência (QI). Um paciente que apresente um resultado do teste QI entre 50-69 é considerado com retardo mental moderado.
42. Muitas síndromes genéticas estão associadas ao retardo mental (deficiência intelectual) e, por isso, há diversas opções de tratamento específico e farmacológico para pacientes com essa doença.
43. A etiologia da deficiência mental pode ser considerada como um construto multifatorial. São fatores de riscos biomédicos na fase do pré-natal: distúrbios cromossômicos; distúrbios de gene único; síndromes; distúrbios metabólicos; disgenesia cerebral; doenças maternas; idade dos pais.
44. Sexualidade é o estado de bem-estar físico, emocional, mental e social; não se refere à mera ausência de doenças, disfunções ou enfermidades. O trabalho com essa temática exige uma abordagem positiva e respeitosa no que tange à sexualidade e a relacionamentos sexuais.
45. O matriciamento em saúde mental é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. No Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, as equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funcionam como equipes de referência interdisciplinares. E a equipe de apoio matricial, no caso, é a equipe de saúde mental.
46. Na psicologia junguiana, também conhecida como psicologia analítica, o psicoterapeuta analisa o comportamento do paciente de forma mais objetiva e costuma focar em problemas específicos, através da investigação das crenças irracionais e negativas do indivíduo. O analista atua para modificar os pensamentos e comportamentos distorcidos.
47. O uso de drogas, inclusive álcool e tabaco, não tem relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde dos adolescentes e jovens, entre os quais destacam-se os acidentes de trânsito, depressões clínicas e distúrbios de conduta, ao lado de comportamento de risco no âmbito sexual e a transmissão do HIV pelo uso de drogas injetáveis e de outros problemas de saúde decorrentes dos componentes da substância ingerida, e das vias de administração.
48. O Delirium Tremens, causado por abstinência alcoólica, é uma grave síndrome que se instala em até 12 minutos após a abstinência e pode levar à morte.
49. São considerados riscos baixos para o suicídio, em adultos, conforme a rede de atenção à saúde: ideação suicida frequente e persistente, sem plano; com ou sem autoagressão (por ex., automutilação); histórico de tentativa; ausência de impulsividade ou abuso/dependência de álcool ou outras drogas.
50. O retardo mental, denominado mais recentemente como deficiência intelectual, é um transtorno neurológico exclusivo da infância e da adolescência.
51. O Projeto Terapêutico Singular é definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido.
52. Os transtornos de aprendizagem são considerados um tipo de transtorno neurodesenvolvimental, que causa discrepâncias entre o potencial e os níveis reais de desempenho acadêmico, assim como as previsões das habilidades intelectuais da pessoa. Envolvem deficiências ou dificuldades na concentração, atenção, linguagem ou processamento visual de informações.
53. O diagrama de abordagem multidimensional (DAM 2) permite a identificação precoce de diversos fatores de riscos, abordando vários aspectos do sofrimento humano e mantendo o foco em objetivos claros que possam aliviar e preparar o paciente e sua família durante o processo de morte.

54. As psicoses agudas caracterizam-se pela perda abrupta do contato com a realidade, tornando-se clinicamente perceptíveis em minutos, horas ou dias. Elas são causadas pelo excesso de íons de Cálcio ou Potássio no sangue.
55. A rede de atenção psicossocial foi instituída pela Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011. Dentre os objetivos gerais dessa portaria, está o de garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.
56. A identificação de fatores de risco e da condição em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à atenção primária um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos de deficiência intelectual. Em um paciente antes dos cinco anos de idade, por exemplo, deve-se avaliar os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor; após os cinco anos, o ideal é promover a avaliação neuropsicológica com aplicação de testes psicométricos.
57. O transtorno de personalidade dependente é caracterizado por uma necessidade generalizada e excessiva de ser cuidado, levando à submissão e comportamentos carentes. A pessoa não acredita que consegue cuidar de si mesma e utiliza a submissão para tentar fazer com que outras pessoas cuidem dela.
58. A assistência geral ao paciente com retardo mental (deficiência intelectual) requer a participação de vários profissionais, tendo o psiquiatra como coordenador dos diversos encaminhamentos para outras especialidades, independentemente das necessidades do quadro clínico.
59. A adolescência é o período de incertezas, turbulências e aprendizados na vida dos seres humanos. O pensamento de suicídio é visto como uma saída para uma situação de sofrimento, que pode acontecer quando há uma depressão grave com baixa autoestima, humor deprimido, sentimento de que não há motivos para viver ou nenhuma chance de ser feliz.
60. A Declaração de Caracas foi o documento que definiu as reformas na atenção à saúde mental nas Américas e norteou as políticas adotadas pelos governos dos países da América Latina. Esse documento foi lançado na Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, organizada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
64. Na palavra PEZINHO, o sufixo “pe-” é acrescido do radical “-inho”, mas, para facilitar a pronúncia, a consoante de ligação “-z-” é utilizada.
65. Considere um triângulo ABC onde $AB = AC$. Sejam também os pontos D e E pertencentes aos lados AB e AC, respectivamente, onde $AB = 4DB$ e $AC = 4AE$. Se a área do quadrilátero BCED é 52 cm^2 , então a área do triângulo ADE é menor que 10 cm^2 .
66. Durante uma festa da empresa, a média de tempo de experiência entre os 25 funcionários presentes é de 4 anos e 3 meses. O número total de funcionários com 4 anos e 9 meses de experiência que precisa participar da festa para elevar a média de tempo de experiência de todos os presentes para 4 anos e 4 meses é superior a 10.
67. O valor máximo que “a” pode assumir para que as equações $a^2 - bc - 8a + 7 = 0$ e $b^2 + c^2 + bc - 6a + 6 = 0$ sejam satisfeitas, considerando os números reais “b” e “c”, é 9.
68. Em “Amanhã vou à cidade”, tem-se um uso do presente do indicativo para retratar uma ação futura.
69. O hífen nos termos “semi-hospitalar”, “proto-história” e “anti-horário” se justifica pela junção de prefixo ou falso prefixo com palavra iniciada por “h”.
70. A vogal “i” deve ser empregada na sílaba final dos verbos terminados em -UAR e -UIR: diminui, habitui, influi e pontui.
71. Na sentença “Mais de um estudante faltaram”, o verbo deve ficar no plural, enquanto em “Menos de dois alunos veio”, o verbo fica no singular porque precisa concordar com o número representado (menos de dois = 1).
72. Com o novo acordo ortográfico, o acento diferencial de “PARA” (verbo), em oposição a “PARA” (preposição), deixou de existir, ficando a cargo do contexto permitir a correta compreensão.
73. Os vocábulos “você”, “saúde”, “prática” e “fóssil” são acentuados por serem, respectivamente, oxítona, paroxítona, proparoxítona e novamente paroxítona.
74. A palavra “rubrica” costuma ser erroneamente pronunciada e grafada como uma proparoxítona (RÚbrica), mas na verdade ela se trata de uma paroxítona, não tendo, portanto, acento gráfico e devendo ser pronunciada como “ruBRlca”.
75. As reclamações apresentadas no protocolo da Câmara Municipal de Ingá – PB, em relação às contas do município, deverão ser apresentadas em três vias, registradas em cartório (Lei Orgânica de Ingá – PB).
76. Havendo vacância dos cargos de Prefeito e Vice-prefeito do Município de Ingá – PB, o Presidente da Câmara poderá recusar assumir a prefeitura, devendo realizar eleições diretas no prazo de 90 dias, independente do momento do mandato (Lei Orgânica de Ingá – PB).
77. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Ingá – PB, os crimes de responsabilidade serão definidos em Lei Especial, devendo obedecer a Lei Federal que trate de normas de processo e julgamento.
78. A Lei Orgânica do Município de Ingá – PB poderá ser emendada mediante proposta individual de qualquer um dos membros da Câmara Municipal.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens subsequentes.

61. Na Língua Portuguesa, atribui-se o nome de “radical” ao núcleo da palavra, no qual reside seu significado.
62. A vogal temática, na Língua Portuguesa, é acrescida ao radical para formar o tema da palavra.
63. No processo de derivação prefixal, na Língua Portuguesa, a palavra primitiva recebe um sufixo precedido de uma vogal atômica. Por exemplo: reconhecer, descrença e injusto.

79. O Estado da Paraíba poderá intervir no Município de Ingá caso não seja aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino (Lei Orgânica de Ingá – PB).
80. O número de Vereadores do Município de Ingá – PB, para cada legislatura, será atualizado de acordo com a população existente, apurada até o último dia do mês de março do ano eleitoral, e atualizado em Lei Estadual.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR

RASCUNHO